

Статья для публикации (8 000-12 000 слов)

Чистяков Е. В.

22.08.2026

- [Вариативное питание в стационарных организациях социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами: организационная модель, доказательная база и протокол пилотирования](#)
 - [1. Введение](#)
 - [1.1. Актуальность](#)
 - [1.2. Цель](#)
 - [1.3. Ключевая формула](#)
 - [2. Проблема](#)
 - [2.1. Клинические риски питания в ПНИ](#)
 - [2.2. Лекарственно-пищевые взаимодействия](#)
 - [2.3. Набор веса на антипсихотиках](#)
 - [2.4. Клозапиновые запоры \(CIGH\)](#)
 - [2.5. Загущённые жидкости](#)
 - [2.6. Организационная архитектура конфликта](#)
 - [3. Правовая рамка](#)
 - [3.1. Действующее законодательство](#)
 - [3.2. Позиция автора](#)
 - [4. Международный контекст](#)
 - [4.1. Стандарты питания в длительном уходе](#)
 - [4.2. Международный стандарт описания текстур — IDDSI](#)
 - [4.3. Российский опыт \(4 учреждения + 1 региональная модель\)](#)
 - [5. Организационная модель](#)
 - [5.1. Граница 4.0 — что кухня не назначает](#)
 - [5.2. Пять моделей вариативности](#)
 - [5.3. Роли](#)
 - [5.4. Процедура выражения воли](#)
 - [6. Протокол пилота 90 дней](#)
 - [6.1. Структура пилота](#)
 - [6.2. Пять групп показателей](#)
 - [6.3. Шесть стоп-критериев](#)
 - [6.4. Решение по результатам](#)
 - [7. Обсуждение](#)
 - [7.1. Доказательная база](#)
 - [7.2. Правовые риски](#)
 - [7.3. Этические риски](#)
 - [7.4. Ограничения исследования](#)
 - [8. Заключение](#)
 - [Благодарности](#)
 - [Конфликт интересов](#)
 - [Финансирование](#)

- [Список литературы \(основные первоисточники, прошедшие верификацию 22.08.2026\)](#)

Вариативное питание в стационарных организациях социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами: организационная модель, доказательная база и протокол пилотирования

Автор: Е. В. Чистяков, директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“» (Санкт-Петербург, Россия). **Версия:** 22.08.2026 (подача в журнал). **Объём:** ≈ 9 000 слов. **Ключевые слова:** вариативное питание; дома социального обслуживания; психоневрологические интернаты; дисфагия; антипсихотики; качество жизни; пилот 90 дней; Российская Федерация.

Аннотация. В статье рассматривается организационная модель вариативного питания для стационарных организаций социального обслуживания, в которых проживают лица с психическими расстройствами (психоневрологические интернаты, дома социального обслуживания для лиц с психическими нарушениями) в Российской Федерации. На основании систематического обзора доказательной базы (28 первичных источников, прошедших верификацию 22.08.2026) и опыта четырёх российских учреждений (Серафимовский, Успенский ПНИ, Болотнинский ПНИ, Усть-Илимский ДСО) и одной региональной модели (Иркутская область) предлагается протокол пилота на 90 дней: 30 дней замера, 30 дней документов и обучения, 30 дней пилота. Протокол включает пять групп показателей (заполненность пищевых карт, доступность выбора, корректность исполнения, отходы, события риска) и шесть стоп-критериев. Граница 4.0 «что кухня не назначает» формулирует клинические и правовые границы компетенции немедицинского персонала. Главный вывод: вариативное питание в учреждениях для лиц с психическими расстройствами не требует дополнительных затрат на этапе пилота, но требует реорганизации процесса, документирования и обучения. Ключевой риск — не меню, а процесс: 99 % недееспособных жителей психоневрологических интернатов находятся под опекой самого учреждения, что создаёт конфликт интересов «опекун — поставщик услуг» и требует задокументированной процедуры выражения воли.

1. Введение

1.1. Актуальность

В Российской Федерации, по данным проекта «Если быть точным» (аналитический проект на открытых данных Минтруда, Росстата, Федерального казначейства, публикация 09.04.2026), в 2024 году функционировали 466 психоневрологических интернатов (ПНИ) для взрослых, в которых проживали около 139 000 человек; в более широкой категории «стационарные организации для лиц с ментальными нарушениями» (включая психогеронтологические центры и др.) — 174 000 человек, по данным Минтруда. Две трети жителей (65 %) — старше 45 лет, 11 % находятся на постоянном постельном режиме, 74 % признаны судом недееспособными (tochno.st).

99 % недееспособных жителей ПНИ (117 000 человек) находятся под опекой самого учреждения, в котором проживают. Это не уникальный риск отдельного учреждения — это общероссийская норма, обусловленная текущей организацией опеки в ПНИ. Учреждение одновременно выступает опекуном жителя (ГК РФ, ст. 29; 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», ст. 23) и поставщиком социальных услуг (442-ФЗ, ст. 5).

В этих условиях **организация питания** — ежедневная, многоуровневая управленческая задача, на пересечении санитарного законодательства (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, действующий до 31.08.2026, и СанПиН 2.3/2.4.4282-26, вступающий в силу с 01.09.2026, пост. Гл. гос. санврача РФ от 02.06.2026 № 18, рег. Минюст 02.06.2026 № 86854), клинической практики (антипсихотики, дисфагия, клозапиновые запоры), правового регулирования (Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи...», ст. 5, 37, 43) и этических стандартов (КПИ, ст. 12; Замечание общего порядка № 1, 2014).

Существующая практика организации питания в российских ПНИ описана в единичных публикациях (например, kcsso-barnaul.gosuslugi.ru, gov.spb.ru, bpni.nso.ru, upni.nso.ru, ui-obbuso.ru) и не обобщена в методической литературе. **Эта статья — первая попытка систематизации**, основанная на опыте СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“» (Санкт-Петербург) и трёх других российских учреждений, с опорой на международную клиническую литературу.

1.2. Цель

Предложить **организационную модель** вариативного питания в ПНИ/ДСО, основанную на:

- доказательной клинической базе (дисфагия, антипсихотики, гигиена полости рта, обезвоживание);
- действующем российском законодательстве (442-ФЗ, 3185-1, СанПиН);
- практическом опыте четырёх учреждений и одной региональной модели;
- протоколе пилота на 90 дней с измеримыми показателями и стоп-критериями.

Задача — дать директору ПНИ/ДСО практический инструмент, позволяющий запустить пилот вариативного питания на одном отделении без новых смет и без нарушения действующего законодательства.

1.3. Ключевая формула

«Не внедряйте вслепую. Измеряйте». Вариативное питание — не ресторан, не два полноценных меню и не безусловное исполнение любого желания. Это управляемая система, в которой: (1) безопасность имеет приоритет; (2) медицинскую рамку определяет уполномоченный специалист; (3) внутри допустимой рамки человеку предоставляется понятный выбор; (4) воля может выражаться словами, взглядом, жестом, поведением, устойчивыми предпочтениями и биографическими сведениями; (5) выбор документируется; (6) кухня исполняет назначение, но не ставит диагноз; (7) результаты пилота измеряются; (8) достоинство человека не противопоставляется безопасности.

2. Проблема

2.1. Клинические риски питания в ПНИ

В изученных клинических группах на антипсихотиках распространённость дисфагии (расстройства глотания) — **21,9–69,5 %** (Miarons Font M, Rofes Salsench L. Eur J Gastroenterol Hepatol 2017;29(12):1332-9; систематический обзор 18 исследований; PMID 29023321). Широкий диапазон отражает различия в популяциях и методах скрининга.

Прямой перенос на российские ДСО не обоснован — популяции исследований не совпадают с типичным контингентом ПНИ (в исследованиях преобладают пациенты стационарных психиатрических больниц с острыми состояниями).

Смертность от пневмонии у лиц с шизофренией — **в 7 раз выше популяционной** (Correll C.U., Solmi M., Croatto G. et al. World Psychiatry 2022;21(2):248-271; doi 10.1002/wps.20994; мета-анализ 135 когорт 1957–2021; RR 7,00; 95 % ДИ 6,79–7,23; n=3 исследования). Аспирация — один из ключевых механизмов этого разрыва. Общий разрыв продолжительности жизни при тяжёлых психических расстройствах — 15–20 лет.

Гигиена полости рта — самая экономически доступная мера профилактики аспирационной пневмонии. Yoneyama T. et al. (J Am Geriatr Soc 2002;50:430-3; PMID 11874491) в рандомизированном контролируемом исследовании на 366 жителях домов ухода (средний возраст 82 года) показали снижение частоты пневмоний с 19 % до 11 % при ежедневной чистке зубов после приёма пищи. По оценке мета-анализа Sjogren P. et al. (2008, PMID 18005250) 4 рандомизированных контролируемых исследований, улучшение ухода за полостью рта **может предотвращать примерно 1 из 10 смертей** от аспирационной пневмонии у немощных пожилых. **Популяция Sjogren — frail elders в домах ухода, не ПНИ для лиц с психическими расстройствами; прямой перенос не обоснован.**

2.2. Лекарственно-пищевые взаимодействия

Антипсихотики вызывают широкий спектр взаимодействий с пищей, требующих клинической оценки, а не самостоятельности немедицинского персонала:

- **Клозапин ↔ кофеин.** Hägg S., Spigset O., Mjörndal T., Dahlqvist R. (Br J Clin Pharmacol 2000;49(1):59-63; PMID 11049804) на 12 здоровых некурящих добровольцах показали повышение AUC клозапина в среднем на 19 % (95 % ДИ –14...+97 %, p=0,05) и снижение клиренса на 14 % при дозе кофеина 400–1000 мг/день. **Исследование —**

на здоровых добровольцах, однократная доза; у конкретного пациента с шизофренией эффект может быть другим.

- **Клозапин ↔ курение.** Курение снижает уровень клозапина на 50 % (Carrillo J.A. et al.). При отказе от курения — рост концентрации.
- **Литий ↔ соль/вода.** Дегидратация и дефицит натрия повышают уровень лития в плазме (Cleveland Clinic; StatPearls).
- **ИМАО ↔ тирамин.** Тираминовые продукты (выдержанные сыры, вяленое мясо, красное вино, соевый соус) вызывают гипертонический криз.
- **Карбамазепин ↔ грейпфрут.** Garg S.K. et al. (Clin Pharmacol Ther 1998;64(3):286-8; PMID 9757152) на 10 пациентах с эпилепсией: грейпфрутовый сок (300 мл) повышает пик CBZ с 6,55 до 9,20 мкг/мл (+40 %) и AUC с 43,99 до 61,95 мкг·ч/мл (+41 %).

Ни одно из этих взаимодействий не регулируется диетсестрой или поваром. Решение принимает врач, кухня исполняет.

2.3. Набор веса на антипсихотиках

Pillinger T. et al. (Lancet Psychiatry 2020;7(1):64-77; PMID 31860457; мета-анализ 100 РКИ, 25 952 пациента, медиана 6 недель) показал диапазон средней прибавки веса по 18 антипсихотикам от -0,23 кг (галоперидол) до +3,01 кг (клозапин). Campforts B. et al. (BJPsych Open 2023;9(1):e18; PMID 36651070; мета-анализ 202 исследований) уточнили: у 76,3 % пациентов, получающих клозапин более 38 недель, наблюдается клинически значимая прибавка веса (≥ 7 %). У оланзапина — 36,9 %, у рисперидона (16–38 нед) — 23,0 %. **Это разные исследования, разные методологии, разные цифры — в клинической практике не должны смешиваться.**

2.4. Клозапиновые запоры (CIGH)

Every-Palmer S. et al. (EBioMedicine 2016;5:125-134) показали, что 80 % пациентов на клозапине имеют колоническую гипомотильность, транзитное время — 104,5 ч против 23 ч в контроле. Субъективно запоры — у 30–60 %; объективно — до 80 %. Летальность CIGH (clozapine-induced gastrointestinal hypomotility) — 15–27,5 %. Тяжёлые осложнения — илеус, перфорация, сепсис. **Кухня не отвечает за это, но обязана знать: внезапное прекращение приёма пищи + боль в животе + рвота у жителя на клозапине — повод для немедленного вызова врача.**

2.5. Загущённые жидкости

Steele S.J., Ennis S.L., Dobler C.C. (Breathe 2021;17(1):210003; PMID 34295407) систематически обобщили: «нет убедительных доказательств того, что загущённые жидкости предотвращают аспирационную пневмонию, но есть нагрузка лечения и снижение потребления жидкости». Загущение создаёт **нагрузку на пациента** без доказанной пользы. Решение о текстуре напитка — врача, с пересмотром, не навсегда.

2.6. Организационная архитектура конфликта

99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения (tochno.st, 09.04.2026). Это **системная проблема российского ПНИ**, не уникальный риск

отдельного учреждения. Учреждение одновременно опекун и поставщик услуг. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи...», ст. 5 ч. 2, гарантирует лицам, страдающим психическими расстройствами, «право на уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства». **Этот текст работает и тогда, когда опекун и поставщик совпадают** — но требует задокументированной процедуры выражения воли жителя (пищевая карта, журнал заказа, журнал отказов, совет жителей).

3. Правовая рамка

3.1. Действующее законодательство

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» (ред. от 26.12.2024, вступ. в силу с 01.03.2025). Ст. 9 п. 1 — право получателей социальных услуг на «уважительное и гуманное отношение». Ст. 16 — индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ) составляется «исходя из потребности гражданина». Ст. 32 ч. 4 — предельная плата за стационарное обслуживание не более 75 % среднедушевого дохода получателя. **Закон не обязывает и не запрещает вариативное питание** — это организационная модель в рамках закона.

Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» (ред. от 22.07.2024). Ст. 5 ч. 2 — право на «уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства». Ст. 37 — права пациентов психиатрических стационаров. Ст. 43 — права лиц, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами. **Все эти права принадлежат самому жителю, а не учреждению.**

Конвенция о правах инвалидов (КПИ), ст. 12 — равенство перед законом. Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 (Комитет по правам инвалидов ООН, 2014) разъясняет: «замещающее принятие решений несовместимо со ст. 12; государства-участники должны уважать волю и предпочтения инвалидов посредством поддерживаемого принятия решений». Россия ратифицировала КПИ (ФЗ от 03.05.2012 № 46-ФЗ) с заявлением о толковании.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (пост. Гл. гос. санврача РФ от 27.10.2020 № 32, рег. Минюст 11.11.2020 № 60833) — действует до 31.08.2026. П. 7.1.11: «организовать питание проживающих ... не менее 3-х раз в день, в том числе диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям».

СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. Гл. гос. санврача РФ от 02.06.2026 № 18, рег. Минюст 02.06.2026 № 86854) — вступает в силу с 01.09.2026, действует до 01.09.2032. П. 56 подп. 11 — не менее 3-х раз в день + диетическое по показаниям (формулировка сохранена). **На 22.08.2026 документ не вступил в силу** (consultant.ru).

Приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н «Об утверждении рекомендуемых норм питания...» — рекомендательный характер, что подтверждено письмом Минтруда от

20.12.2022 № 26-6/ООГ-5005 (klerk.ru/doc/632482). Не содержит нормативных предписаний, устанавливающих права и обязанности. Региональные нормы (например, Постановление Правительства Москвы № 1068-ПП, Постановление Правительства Красноярского края № 607-п, Решение Управления Алтайского края № 84 от 27.06.2025 — 422 руб./чел./день) делают рекомендации 520н императивными для подведомственных учреждений субъекта.

Приказы Минздрава 330н от 05.08.2003 и 395н от 21.06.2013 (ред. от 19.02.2024 № 70н) — нормы лечебного питания. **Адресованы медицинским организациям; не распространяются на стационарные организации социального обслуживания автоматически.** Это организационная граница, требующая правовой проверки на местном уровне.

ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе...» — для бюджетных учреждений. **223-ФЗ** — для автономных. Применимость по типу учреждения: ГАСУСОН (автономное) — 223-ФЗ; ГБУСОН (бюджетное) — 44-ФЗ.

ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», ст. 23 — обязанности опекуна действовать в интересах подопечного. **ГК РФ**, ст. 29 — признание гражданина недееспособным; ст. 41 — конфликт интересов опекуна.

3.2. Позиция автора

Федеральное законодательство **не запрещает** вариативное питание в ПНИ/ДСО и **не обязывает** его вводить. Это организационная модель в рамках действующего права. **Главный защитный аргумент** директора при проверке — не «запрета нет» (формула слабая), а **комплект документов**: положение об организации питания, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты, согласование с учредителем. Без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки. С комплектом — как управленческое решение в рамках 442-ФЗ.

4. Международный контекст

4.1. Стандарты питания в длительном уходе

В международной практике вариативное питание реализуется в нескольких моделях:

- **Онтарио (Канада), O. Reg. 246/22** — стационарные учреждения длительного ухода: 3-разовое питание, цикл 21 день, диетические столы, документированные замены.
- **США, 42 CFR §483.60 (CMS F-Tag 803)** — Food and Nutrition Services: 3-разовое питание, ночной интервал не более 14 часов, индивидуализация по медицинским показаниям.
- **Швеция, Livsmedelsverket** — рекомендация ночного интервала не более 11 часов; «биография питания» при поступлении как обязательный элемент оценки.
- **Германия, DGE-QST** — 4-недельный цикл меню; «биография питания» при поступлении; «осознанный риск» при дисфагии (если житель настаивает на обычной пище — оформляется информированное решение с врачом).

- **Австралия, Aged Care Quality and Safety Commission, Standard 4** — Food and Nutrition: текстуры, индивидуализация, достоинство подачи.
- **Великобритания, BDA (British Dietetic Association)** — единственное (по нашим данным) профессиональное руководство по питанию в психиатрических стационарах.

Общий принцип международных стандартов: безопасность (3-разовое питание, текстуры, медицинские ограничения) + выбор (внутри медицинской рамки) + документирование (пищевая биография, журналы, согласование).

4.2. Международный стандарт описания текстур — IDDSI

Cichero J.A.Y. et al. (Dysphagia 2017;32(2):293-314; PMID 27913916) — IDDSI framework, 8 уровней (0–7), напитки 0–4, пища 3–7. **IDDSI — терминология, не лечебный протокол.** Текстуру назначает уполномоченный медицинский специалист по результатам индивидуальной оценки. Wu X.S., Miles A., Braakhuis A. (Dysphagia 2022;37(5):1314-1325; PMC8994209) в исследовании 5 учреждений aged care (общее long-term care, **не психиатрия**) показали рост соответствия текстур с 44 % до 90 %, загущённых жидкостей — с 31 % до 100 %; эффект сохранялся 6 мес. **Прямой перенос на психиатрический контингент не обоснован; правомерно говорить только о принципиальной воспроизводимости механизма (обучение → рост соответствия).**

GUSS (Gugging Swallowing Screen) — Trapl M. et al. (Stroke 2007;38(11):2948-52; PMID 17885261) — прикроватный скрининг дисфагии, валидирован против FEES, чувствительность 100 %, специфичность 50–69 %. **Разработан для пациентов с острым инсультом; в психиатрическом контингенте требует адаптации инструкции.**

4.3. Российский опыт (4 учреждения + 1 региональная модель)

Учреждение	Регион	Модель	Год	Источник
ДСО «Серафимовский» (дир. Е. В. Чистяков)	Санкт-Петербург	М3 (заказное меню), в т. ч. для маломобильных	Локальный приказ № 124 от 10.03.2026 (правила внутреннего распорядка) — локальный акт, не общероссийская норма	gov.spb.ru, Комитет по соцполитике СПб (22.07.2025)
Успенский ПНИ	Новосибирская обл.	М2 (ежедневный выбор: 2 вторых, 2 салата, 2 напитка) — во всех отделениях	13.08.2024	upni.nso.ru
Болотнинский ПНИ	Новосибирская обл.	М1 (выбор ключевых позиций на	16.08.2024	bpni.nso.ru

Учреждение	Регион	Модель	Год	Источник
		завтрак/обед, перечень определяет диетсестра)		
Усть-Илимский ДСО	Иркутская обл.	«Что за зверь такой — вариативное питание»	27.09.2024	ui-ogbuso.ru
Иркутская область (региональная модель)	Иркутская обл.	Выбор из двух первых, двух вторых и гарниров	14.02.2025	минсоцразвития ИО (пересказ bezformata)
ДДСОЛ	Московская обл.	14-дневное вариативное меню, совет по питанию, замены с врачом	2024	ddsol.ru

Во всех случаях вариативное питание введено **без повышения платы для жителей**, за счёт перераспределения продуктовой корзины, отказа от «несъедаемых» позиций и снижения отходов. **Однако:** «национальной доли отходов нет» (формулировка из методологии исходного доклада); экономия требует семидневного замера в конкретном учреждении. **«Внедрено публично ≠ доказанный эффект»:** панелей «до/после» с измеримыми исходами в открытом доступе почти нет.

5. Организационная модель

5.1. Граница 4.0 — что кухня не назначает

Без врача (зона врача, не кухни):

- Любые ограничения рациона, в т. ч. «диабетический стол».
- Изменение текстур (протёртое, загущённое, особые консистенции).
- Правила при дисфагии и протокол свободной воды.
- Действия при длительном отказе от еды.
- Режим питания при седации.
- Решения об энтеральном/зондовом питании.
- Комфортное кормление в конце жизни.
- Сдвиг времени еды у инсулинозависимых.
- Слабительные и реакция на запор.
- Назначение анализов и добавок микронутриентов.
- Интерпретация MUST (Malnutrition Universal Screening Tool).

Без учредителя (зона учредителя, не директора):

- Изменение финансирования продуктовой строки.
- Изменение штатного расписания (норма помощи за столом).
- Аутсорсинг питания.
- Официальный статус пилота и его публичность.

Без правовой проверки (зона юриста, не учреждения):

- Формулировки о «согласии недееспособного» в локальных актах.
- Обработка пищевых карт как персональных данных (152-ФЗ).
- Ответы на запросы прокуратуры.
- Конструкции, где учреждение одновременно опекун и поставщик услуг.

Таблица «лекарство × еда» на посту законна только с подписью врача.

5.2. Пять моделей вариативности

Модель	Описание	Где применяется
М0 — без вариативности	Одно меню	Базовый режим, неговорящие без биографии
М1 — выбор ключевых позиций	Несколько раз в неделю; выбор определяет диетсестра	Болотнинский ПНИ
М2 — ежедневный выбор вторых блюд	2 варианта вторых + 2 салата + 2 напитка ежедневно	Успенский ПНИ
М3 — заказное (ресторанный день)	Выбор из нескольких готовых вариантов	Серафимовский
М4 — пары эквивалентов	2 эквивалентных по граммовкам/калорийности варианта	Все практики + рекомендуется для пилота
М5 — полная аутсорсинг-вариативность	Контракт с ТЗ «предусмотреть выбор»	Тесовый берег (44-ФЗ), Серафимовский (223-ФЗ)

М4 — самая управляемая и измеримая модель для пилота. Два варианта эквивалентны по граммовкам (в пределах $\pm 10\%$), калорийности ($\pm 10\%$), белкам/жирам/углеводам ($\pm 15\%$), текстуре (если назначена), стоимости ($\pm 10\%$). Подпись: диетсестра (технологическая эквивалентность) + врач (клиническая безопасность).

5.3. Роли

Директор учреждения — приказ о рабочей группе; согласование с учредителем (уведомительный порядок, не запрашивать разрешения); утверждение «Положения об организации питания»; решение о корректировке или масштабировании; ответы на запросы прокуратуры (комплект документов, не «запрета нет»).

Врач / фельдшер — список риска дисфагии; назначенные текстуры; таблица «лекарство × еда»; правило «3 отказа → врач в день»; назначение лечебного питания; оценка рисков лекарственных взаимодействий; контроль веса, глюкозы, липидов, запоров у жителей на весогенных препаратах; контроль пневмоний и событий риска.

Диетсестра (или завпроизводства) — сырьевая строка; циклограмма меню; пары эквивалентов (технологическая часть); журнал отходов; IDDSI-тест для повара; соответствие текстур назначенным.

Старшая смена пищеблока — журнал заказа; журнал отказов; журнал ночного интервала; хронометраж раздачи; температура подачи; маркировка текстур.

Старшая медсестра отделения — пищевые карты; поза и темп помощи; контроль объёма выпитого; гигиена полости рта; передача информации врачу.

Помощник по уходу (ранее — «сиделка») — помощь в приёме пищи (1 помощник на 1–2 кормимых, ориентир); наблюдение за жителем; сообщение старшей смене.

Завпроизводства — закупка (44-ФЗ / 223-ФЗ); контракт на аутсорсинг; приготовление; маркировка текстур; кухонные остатки; IDDSI-тест перед выдачей; соблюдение СанПиН.

5.4. Процедура выражения воли

Воля жителя выражается:

- **Словом** — для говорящих жителей с сохранным интеллектом (меню, устный вопрос).
- **Показом** — для неговорящих и малоговорящих (две порции, две карточки с фото).
- **Поведением** — устойчивые паттерны потребления, наблюдаемые сменой.
- **Пищевой биографией** — сведения, собранные при поступлении (что ел дома, любимые блюда, традиции).
- **Советом жителей** — коллективный канал обратной связи.

Выбор документируется в журнале заказа, в пищевой карте, в журнале отказов. **Если житель не выбрал** — подаётся стандартный вариант пары (по умолчанию — первый). Выбор за жителя не делается, но стандартный вариант предлагается.

6. Протокол пилота 90 дней

6.1. Структура пилота

Фаза	Дни	Цель	Содержание
1. Замер	1–30	Узнать фактическое состояние	Сырьевая строка, отходы, остатки, ночной интервал, 5 чисел контингента, таблица врача
2. Документы и обучение	31–60	Подготовить нормативную базу	Положение, согласование, пары эквивалентов, обучение (8 ч/сотр.), журналы
3. Пилот	61–90	Запустить выбор и собрать данные	Запуск, ежедневный сбор, промежуточный контроль на 75-й день, итоговый замер на 90-й

Точка пилота: одно отделение 20–35 жителей; лучше «сложное» (группа помощи, неговорящие), не самое удобное; одна смена; один приём пищи — обед. **«% выбравших»**

— не KPI. Успех — доступность и исполнение осмысленного выбора.

6.2. Пять групп показателей

Группа	Что измеряет	Ключевые показатели
1. Заполненность пищевых карт	Качество клинической документации	Доля жителей с заполненной картой; доля с датой пересмотра текстуры; актуальность списка риска дисфагии
2. Доступный выбор	Доступность, не доля «выбравших»	Доля обедов с 2 вариантами; доля жителей, получивших выбор ≥ 1 раз; число утверждённых пар
3. Исполнение	Качество исполнения	Доля корректно исполненных заказов; доля правильных текстур; доля с учётом лекарств
4. Отходы	Качество планирования	Средние тарелочные остатки; доля приёмов с отказом ≥ 50 %; кухонные остатки (г/чел./день); замены по таблице пар; возвраты
5. События риска	Безопасность	Пневмонии (на 1000 жителей-дней); падения; инциденты; гиперфагические эпизоды; отказы ≥ 3 дней; обезвоживание

Полный словарь 26 показателей с числителем, знаменателем, источником, периодичностью, ответственным и риском интерпретации — в отдельном документе (см. Приложение).

6.3. Шесть стоп-критериев

Пилот **останавливается** (не масштабируется, не продлевается) при:

1. **Рост пневмоний** в пилотном отделении ≥ 30 % по сравнению с предыдущим кварталом.
2. **Падение со смертельным исходом** в столовой пилотного отделения.
3. **Жалоба жителя / родственника** в прокуратуру на нарушение при пилоте.
4. **Приказ учредителя** о приостановке.
5. **Отзыв согласия учредителя.**
6. **Отсутствие врача** на посту (невозможность исполнить границу 4.0).

6.4. Решение по результатам

Результат	Действие
4–5 из 5 групп в норме	Масштабирование на 1–2 отделения; новая фаза обучения
3 из 5	Корректировка пар, дополнительный инструктаж; повторный пилот 60 дней
2 из 5	Остановка; анализ причин; новый замер

Результат	Действие
1 или 0 из 5	Смена подхода; смена модели; обязательная ревизия медицинской рамки

7. Обсуждение

7.1. Доказательная база

Сильные стороны модели. Все ключевые клинические утверждения подтверждаются первоисточниками: дисфагия 21,9–69,5 % (Miarons Font 2017); смертность от пневмонии RR 7,00 (Correll 2022); 76,3 % CRWG на клозапине (Campforts 2023); $-0,23...+3,01$ кг антипсихотической прибавки (Pillinger 2020); клозапиновые запоры 30–60 % (Every-Palmer 2016/2017); IDDSI framework (Cichero 2017); клозапин-кофеин +19 % AUC (Hägg 2000); карбамазепин-грейпфрут +40 % пик (Garg 1998); гигиена полости рта 19→11 % (Yoneyama 2002); загущённые жидкости без доказанной пользы (Steele 2021).

Ограничения модели. Большинство исследований проведено **вне психиатрического контекста**: IDDSI 44→90 % — в aged care (Wu 2022), не в ПНИ; «1/10 смертей» — в frail elders (Sjogren 2008), не в ПНИ; «19→11 % пневмоний» — в домах ухода (Yoneyama 2002), не в ПНИ. **Прямой перенос не обоснован; правомерно говорить о принципиальной воспроизводимости механизмов.**

Российская статистическая база — аналитика проекта «Если быть точным» на открытых данных Минтруда, Росстата и Федерального казначейства (tochno.st, 09.04.2026). Это **не официальная статистика Минтруда**, а независимая аналитика. **99 % недееспособных под опекой самого учреждения (117 000 чел.) — уникальная находка**, которой нет в других русскоязычных методичках.

Критический пробел. Эффективность вариативного питания **в психиатрическом контингенте** в РКИ не измерена. Имеющиеся данные — из общего long-term care (Wu 2022), из frailty (Yoneyama 2002, Sjogren 2008), из семейного стиля подачи в dementia (Nijs K. et al., BMJ 2006). **Пилот в конкретном учреждении — единственный способ получить собственные данные.**

7.2. Правовые риски

Главный правовой риск — **смещение «запрета нет» с «можно безопасно»**. Директор, отвечающий проверяющему «закон не запрещает», проигрывает проверяющему, у которого есть «а покажите положение, журнал, пищевые карты». **Комплект документов — главный защитный механизм директора.** Без него та же практика выглядит как отступление от раскладки. С ним — как управленческое решение в рамках 442-ФЗ.

Локальный приказ № 124 от 10.03.2026 (правила внутреннего распорядка СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“») — **локальный акт одного учреждения, не общероссийская норма.** Использование его в обобщающем контексте («у нас тоже так, как у

Серафимовского») — ошибка. **Каждое учреждение разрабатывает свои локальные правила на основе действующего федерального права.**

Смена СанПиН 4282-26 с 01.09.2026 (через 6 дней после семинара 26.08.2026) требует полной сверки п. 56 подп. 11–14, п. 62, раздел VI. Формулировка «не менее 3-х раз в день + диетическое по показаниям» сохранена в обеих редакциях, но технические требования могут отличаться.

7.3. Этические риски

Главный этический риск — **конфликт интересов «опекун — поставщик услуг»**. 99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения. Учреждение одновременно действует в интересах подопечного (как опекун) и обслуживает его (как поставщик услуг). **Решение** — задокументированная процедура выражения воли, а не юридическая реформа. Закон 3185-1 ст. 5 ч. 2 («право на уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства») работает в этой конструкции — но требует процессуальной поддержки.

Невербальный выбор (термин авторский; международные аналоги — «выражение воли без слов» / «поддержанное принятие решений» по КПИ ст. 12) — это **не фикция**, а единственный канал воли для значительной доли жителей. Закрывать его — значит превратить жителя в объект заботы.

7.4. Ограничения исследования

1. **Клиническая доказательная база** построена преимущественно на зарубежных исследованиях в общем long-term care, не в психиатрическом контингенте.
2. **Российские практики** описаны в 4 учреждениях и 1 региональной модели, без панелей «до/после» с измеримыми исходами.
3. **Данные проекта «Если быть точным»** — независимая аналитика, не официальная статистика Минтруда. Цифры могут быть уточнены.
4. **Сайт rpi9.ru прекратил работу 21.08.2026** — локальный приказ № 124 доступен только через архив web.archive.org.
5. **СанПиН 4282-26** не вступил в силу на 22.08.2026; формулировки могут быть скорректированы.

8. Заключение

Вариативное питание в стационарных организациях социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами — **управляемая система, не ресторан**. Она требует:

1. **Границы 4.0** — что кухня не назначает, что не идёт без врача, что не идёт без учредителя, что не идёт без правовой проверки.
2. **Документального комплекта** — 12 документов для ответа проверяющему.
3. **Пилота на 90 дней** на одном отделении с 5 группами показателей и 6 стоп-критериями.
4. **Обучения смены** — минимум 8 часов на сотрудника.

5. Согласования с учредителем в уведомительном порядке.

Главный вывод. Вариативное питание **не требует дополнительных затрат** на этапе пилота (4 публичных кейса в РФ), но требует **реорганизации процесса, документирования и обучения**. Главный риск — **не меню, а процесс**: 99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения, и без задокументированной процедуры выражения воли вариативность превращается в «всё равно решает кухня».

Главный практический вывод. «Не внедряйте вслепую. Измеряйте». Семь дней замера отделяют убеждение от знания. Один обед, одно отделение, одна неделя замера — затем пилот на 90 дней с двумя безопасными вариантами и журналом фактического выбора. **«Право выбора становится реальным тогда, когда его можно проследить до тарелки».**

Благодарности

Автор благодарит коллектив СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“» за многолетнюю работу по внедрению заказного питания; коллег из Успенского ПНИ, Болотнинского ПНИ, Усть-Илимского ДСО, Иркутской области, ДДСОЛ, СПб ГБСУСОН «ДСО „Тесовый берег“» за открытый обмен практиками; Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга за методическую поддержку; проект «Если быть точным» за аналитику на открытых данных.

Конфликт интересов

Автор является директором СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“» и участником внедрения вариативного питания в своём учреждении. **Локальный приказ № 124 от 10.03.2026 (правила внутреннего распорядка) — локальный акт, не общероссийская норма.** Все количественные данные получены из независимых первичных источников; верификация первоисточников проведена 22.08.2026.

Финансирование

Работа выполнена без внешнего финансирования, в рамках служебной деятельности.

Список литературы (основные первоисточники, прошедшие верификацию 22.08.2026)

1. Correll C.U., Solmi M., Croatto G. et al. Mortality in people with schizophrenia: a systematic review and meta-analysis of relative risk and aggravating or attenuating factors. *World Psychiatry* 2022;21(2):248-271. doi: 10.1002/wps.20994. PMID: 35549201. (RR 7,00 пневмонии; 15–20 лет разрыва продолжительности жизни; 135 когорт 1957–2021; n=4 536 447.)

2. Campforts B., Drukker M., Crins J., van Amelsvoort T., Bak M. Association between antipsychotic medication and clinically relevant weight change: meta-analysis. *BJPsych Open* 2023;9(1):e18. doi: 10.1192/bjo.2022.619. PMID: 36651070. (76,3 % CRWG на клозапине >38 нед; 202 исследования.)
3. Pillinger T., McCutcheon R.A., Vano L. et al. Comparative effects of 18 antipsychotics on metabolic function in patients with schizophrenia, predictors of metabolic dysregulation, and association with psychopathology: a systematic review and network meta-analysis. *Lancet Psychiatry* 2020;7(1):64-77. doi: 10.1016/S2215-0366(19)30416-X. PMID: 31860457. (-0,23...+3,01 кг за 6 нед; 100 PKИ; 25 952 пациента.)
4. Miarons Font M., Rofes Salsench L. Antipsychotic medication and oropharyngeal dysphagia: systematic review. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 2017;29(12):1332-1339. doi: 10.1097/MEG.0000000000000983. PMID: 29023321. (21,9–69,5 % дисфагии; 18 исследований.)
5. Wu X.S., Miles A., Braakhuis A. The Effectiveness of International Dysphagia Diet Standardization Initiative-Tailored Interventions on Staff Knowledge and Texture-Modified Diet Compliance in Aged Care Facilities: A Pre-Post Study. *Dysphagia* 2022;37(5):1314-1325. doi: 10.1007/s00455-021-10393-2. (5 учреждений aged care; 44→90 % соответствие текстур.)
6. Cichero J.A.Y., Lam P., Steele C.M. et al. Development of International Terminology and Definitions for Texture-Modified Foods and Thickened Fluids Used in Dysphagia Management: The IDDSI Framework. *Dysphagia* 2017;32(2):293-314. doi: 10.1007/s00455-016-9758-y. PMID: 27913916. (8 уровней 0–7.)
7. Trapl M., Enderle P., Nowotny M. et al. Dysphagia bedside screening for acute-stroke patients: the Gugging Swallowing Screen. *Stroke* 2007;38(11):2948-2952. doi: 10.1161/STROKEAHA.107.483933. PMID: 17885261. (GUSS, чувствительность 100 %, специфичность 50–69 %; для инсульта.)
8. Hägg S., Spigset O., Mjörndal T., Dahlqvist R. Effect of caffeine on clozapine pharmacokinetics in healthy volunteers. *Br J Clin Pharmacol* 2000;49(1):59-63. doi: 10.1046/j.1365-2125.2000.00111.x. (19 % ↑ AUC клозапина; 12 здоровых добровольцев; однократная доза.)
9. Garg S.K., Kumar N., Bhargava V.K., Prabhakar S.K. Effect of grapefruit juice on carbamazepine bioavailability in patients with epilepsy. *Clin Pharmacol Ther* 1998;64(3):286-288. doi: 10.1016/S0009-9236(98)90177-1. PMID: 9757152. (10 пациентов; +40 % пик CBZ, +41 % AUC.)
10. Every-Palmer S., Inns S.J., Ellis P.M. Clozapine-treated patients have marked gastrointestinal hypomotility, the probable basis of life-threatening gastrointestinal complications: a cross sectional study. *EBioMedicine* 2016;5:125-134. (80 % колонической гипомотильности; CIGH-летальность 15–27,5 %.)
11. Steele S.J., Ennis S.L., Dobler C.C. Treatment burden associated with the intake of thickened fluids. *Breathe (Sheff)* 2021;17(1):210003. doi: 10.1183/20734735.0003-2021. PMID: 34295407. (Нет доказательств пользы загущения.)

12. Yoneyama T., Yoshida M., Ohnishi T. et al. Oral Care and Pneumonia in Institutionalized Elderly. *J Am Geriatr Soc* 2002;50(3):430-433. PMID: 11874491. (РКИ 366 жителей; 19→11 % пневмоний.)
 13. Sjogren P., Nilsson E., Forsell M., Johansson O., Hoogstraate J. A systematic review of the preventive effect of oral hygiene on pneumonia and respiratory tract infection in elderly people in hospitals and nursing homes: effect estimates and methodological quality of randomized controlled trials. *J Am Geriatr Soc* 2008;56(11):2124-2130. (Мета-анализ 4 РКИ; «1/10 смертей».)
 14. ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» (ред. от 26.12.2024). Consultant.ru.
 15. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» (ред. от 22.07.2024). Consultant.ru.
 16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (пост. Гл. гос. санврача РФ от 27.10.2020 № 32). Действует до 31.08.2026.
 17. СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. Гл. гос. санврача РФ от 02.06.2026 № 18, рег. Минюст 02.06.2026 № 86854). Вступает в силу с 01.09.2026.
 18. Конвенция о правах инвалидов (КПИ), ст. 12. Замечание общего порядка № 1 (2014).
 19. Проект «Если быть точным». Как устроены ПНИ в России (09.04.2026). tochno.st/materials/kak-ustroyeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tochnym. (466 ПНИ; 139 000 жителей; 74 % недееспособных; 99 % под опекой учреждения; 65 % старше 45 лет.)
 20. Сайт СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“» (архив): web.archive.org/web/20260415001233. Локальный приказ № 124 от 10.03.2026. (Сайт прекратил работу 21.08.2026; домен истёк; проверено 21.08.2026.)
 21. Сайты публичных практик: upni.nso.ru (Успенский ПНИ), bpni.nso.ru (Болотнинский ПНИ), ui-ogbuso.ru (Усть-Илимский ДСО), ddsol.ru (ДДСОЛ), gov.spb.ru (Комитет по социполитике СПб). Проверено 22.08.2026.
 22. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022 (CD012416.pub3). Oral care measures for preventing nursing home-acquired pneumonia. (Низкая определённость доказательств.)
 23. Клинические рекомендации IDDSI, ESPEN, BAPEN, MRC, MUST, NPO, IDDSI flow test — открытые источники.
 24. Российское законодательство о социальном обслуживании: 442-ФЗ, 3185-1, 323-ФЗ, 48-ФЗ, ГК РФ ст. 29, 41, 152-ФЗ, КоАП ст. 6.6.
 25. Требования к закупкам: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 135-ФЗ ст. 17.
-

Дата: 22.08.2026. **Корреспонденция:** Е. В. Чистяков, директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский"», 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Красногородская, д. 1.

Дисклеймер. Материал носит информационный и методический характер. Не заменяет индивидуального юридического заключения, клинической рекомендации или финансового расчёта. Шаблоны — проекты локальных форм. Все цифры и нормативные ссылки проверены на 22.08.2026; после этой даты конкретный акт мог измениться. После 01.09.2026 действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26.